

TEMA 1.6 • PEDIATRÍA

Temas de Neurología Pediátrica

PERFIL EUNACOM 2.01.1.083

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Temas de Neurología Pediátrica: Parálisis Cerebral, Síndromes Tónicos y Desarrollo Psicomotor

1. Parálisis Cerebral (PC)

- Definición clínica:
- Retraso del desarrollo psicomotor (RDSM)
- No retrocede en los hitos ya adquiridos (progres a lentamente, pero no regresa)
- 70% espasticidad | 30% hipotonía
- Inteligencia normal en ~80% (alteración motora, no cognitiva en la mayoría)

Causas:

TABLA 1.6.1: MOMENTO VS CAUSAS			
MOMENTO	CAUSAS		
Antenatal	TORCH, infecciones connatas, genopatías		
Intraparto	Asfisia neonatal (la más importante; prevenible)		
Posnatal	Meningitis bacteriana, kernicterus (ictericia neonatal mal manejada)		

PERLA CLÍNICA EUNACOM

El kernicterus (encefalopatía hiperbilirrubinémica) es una causa de parálisis cerebral **completamente prevenible** con el manejo adecuado de la ictericia neonatal.

Diagnóstico: Clínico (RDSM + no retroceso de hitos).

Tratamiento: Enfoque **multidisciplinario**, estimulación y rehabilitación. En Chile: **Fundación Teletón**.

2. Síndrome Hipotónico y Síndrome Hipertónico del RN

Tono normal del RN: Flexor (manos, caderas, extremidades en flexión) + reflejos arcaicos simétricos + movilidad normal.

- Síndrome hipertónico: Tono aumentado, espasticidad
- Síndrome hipotónico: Tono plácido o extensor

Clasificación etiológica

TABLA 1.6.2: TIPO VS FRECUENCIA			
TIPO	FRECUENCIA	CAUSAS PRINCIPALES	CLÍNICA ORIENTADORA
Central	~80%	EHI (asfisia), genopatías (Sd. de Angelman), alteraciones del SNC	Convulsiones, compromiso de conciencia, signos focales
Periférico	~20%	Hipomagnesemia (más frecuente periférica), neuropatías, miopatías (distrofia miotónica)	Reflejos disminuidos, hipoventilación, CK elevada

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La asfisia puede producir **tanto** síndrome hipotónico central (EHI) **como** miopatía hipóxica (causa periférica) con CK elevada. No son mutuamente excluyentes.

- Estudio:
- Siempre primero: electrolitos (incluyendo **magnesio**) + CK
- Causa **central** → **Neuroimagen** (ecografía transfontanelar, RM)
- Causa **periférica** → **Electromiografía (EMG)** (diferencia neuropatía vs. miopatía)

Complicación más importante del síndrome hipotónico: **Hipoventilación** (debilidad de músculos respiratorios).

3. Reflejos Arcaicos (Reflejos Primitivos)

Presentes al nacer; su desaparición sigue un cronograma fijo. Su persistencia más allá del tiempo esperado → daño neurológico.

TABLA 1.6.3: REFLEJO VS ESTÍMULO			
REFLEJO	ESTÍMULO	RESPUESTA	DESAPARECE A
Succión	Insertar chupete, pezón o dedo	Succión rítmica	~3 meses
Búsqueda (rooting)	Rozar la mejilla	Se gira hacia el lado estimulado	~3 meses
Marcha automática	Sostener RN de pie sobre superficie	Movimientos de marcha	~3 meses
Prensión palmar	Dedo en palma	Cierra la mano	~3 meses
Moro	Susto o caída brusca de cabeza	Extensión + abducción de brazos luego flexión	~6 meses
Prensión plantar	Dedo en planta del pie	Cierra los dedos del pie	~9-10 meses

NOTA CLÍNICA

El reflejo de Moro es el que dura más (hasta 6 meses). La prensión plantar dura hasta los 9-10 meses (cuando comienza a ponerse de pie).

4. Desarrollo Psicomotor Normal (Resumen)

Conocer los hitos del desarrollo es fundamental para detectar retrasos:

TABLA 1.6.4: EDAD VS HITO MOTOR GRUESO		
EDAD	HITO MOTOR GRUESO	HITO FINO / SOCIAL
2 meses	Sostiene cabeza boca abajo	Sonrisa social
4 meses	Sostiene cabeza sentado	Sigue objetos
6 meses	Se sienta con apoyo	Balbucea
9 meses	Se sienta solo, gatea	Pinza gruesa
12 meses	Camina con apoyo	Primeras palabras, pinza fina
18 meses	Camina solo bien	10-15 palabras
24 meses	Sube escaleras alternando	Frases de 2 palabras

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla mnemotécnica: "**1-2-3-6-9-12**" → sentarse, gatear, caminar - 6 meses: sienta con apoyo - 9 meses: sienta solo + gatea - 12 meses: camina (con apoyo) - 15 meses: camina solo

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Niño de 2 años, sin antecedentes, presenta episodio de 3 minutos de sacudidas generalizadas con pérdida de conciencia durante fiebre de 39.5°C. Cede espontáneamente. Post-crisis: somnoliento pero reactivo. ¿Cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Temas de Neurología Pediátrica. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Parálisis cerebral: daño motor no progresivo en encéfalo inmaduro; espástica >70%, causa: prematuridad/hipoxia
- Convulsión febril simple: >38°C, 6m-6 años, <15 min generalizada, única; no requiere anticonvulsivantes
- Crisis epiléptica: ABC + benzodiacepinas; DZP rectal 0.5 mg/kg o midazolam bucal/nasal 0.2 mg/kg
- Síndrome hipotónico: central (PC alterado, reflejos normales) vs periférico (reflejos abolidos, fasciculaciones)
- Reflejos arcaicos: Moro desaparece a los 3-6m, prensión palmar 3-4m, Babinski normal hasta 2 años
- Epilepsia: ≥2 crisis no provocadas; EEG y neuroimagen; primera línea: levetiracetam o ácido valproico

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TEMAS DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA)**PREGUNTA 1**

Niño de 2 años, sin antecedentes, presenta episodio de 3 minutos de sacudidas generalizadas con pérdida de conciencia durante fiebre de 39.5°C. Cede espontáneamente. Post-crisis: somnoliento pero reactivo. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Iniciar anticonvulsivantes profilácticos de forma crónica
- B)** Hospitalizar para EEG y RM cerebral urgente
- C)** Buscar foco de fiebre, tratar la causa y educación familiar; no anticonvulsivantes
- D)** Punción lumbar para descartar meningitis bacteriana
- E)** Administrar diazepam rectal en domicilio como protocolo

PREGUNTA 2

Niño de 4 años lleva 8 minutos con crisis tónico-clónica generalizada activa, sin responder a estimulación. No hay acceso venoso disponible. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea?

- A)** Fenitoína EV 20 mg/kg
- B)** Fenobarbital EV 20 mg/kg
- C)** Midazolam bucal o intranasal 0.2 mg/kg
- D)** Esperar hasta 15 minutos antes de intervenir
- E)** Glucosa IV empírica ante sospecha de hipoglicemia

PREGUNTA 3

Lactante de 6 meses con hipotonía marcada desde el nacimiento, llanto débil, reflejos osteotendinosos abolidos y fasciculaciones linguales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Síndrome de Down
- B)** Hipotiroidismo congénito
- C)** Atrofia muscular espinal tipo I (Werdnig-Hoffmann)
- D)** Parálisis cerebral hipotónica
- E)** Miastenia gravis neonatal transitoria

RESUMEN: TEMAS DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA

:::tip El kernicterus (encefalopatía hiperbilirrubinémica) es una causa de parálisis cerebral completamente prevenible con el manejo adecuado de la ictericia neonatal. ::: Tono normal del RN: Flexor (manos, caderas, extremidades en flexión) + reflejos arcaicos simétricos + movilidad normal. :::warning La asfixia puede producir tanto síndrome hipotónico central (EHI) como miopatía hipóxica (causa periférica) con CK elevada. No son mutuamente excluyentes. :::